

أولاً: الحمى:

العلامات السريرية للحمى:

- ١- زيادة ضربات القلب.
- ٢- زيادة عدد مرات التنفس.
- ٣- الرعشة.
- ٤- الضعف.
- ٥- ازرقاق سرير الظفر.
- ٦- زيادة العطش.
- ٧- فقدان الشهية.

المداخلات التمريضية للمريض المصاب بالحمى

- ١- مراقبة العلامات الحيوية.
- ٢- تقييم لون الجلد والحرارة.
- ٣- مراقبة تعداد الكريات البيض والهيماتوكريت والقيم المخبرية الأخرى ذات العلاقة.
- ٤- غرز البطانيات الزائدة عندما يشعر المريض بالدفء وتغطية المريض أكثر عندما يشعر بالبرودة.
- ٥- إعطاء المريض وارداً كافياً من الطعام والسوائل (٢٥٠٠-٣٠٠٠ مل) لتأمين احتياجات الاستقلاب الزائدة ومنع حدوث التجفاف.

٦- قياس الوارد والصادر.

٧- المحافظة على السوائل الوريدية الموصوفة.

٨- إنقاص الفعالية الجسدية لتحديد إنتاج الحرارة.

٩- إعطاء خافضات الحرارة حسب أمر الطبيب.

١٠- العناية بصحة الفم لإبقاء الأغشية المخاطية رطبة، حيث قد تتجفف الأغشية المخاطية وتتشنج نتيجة فقدان الماء الشديد.

الشديد.

١١- إجراء الحمام لزيادة الضياع الحروري بالتوصيل، ويحتاج لأمر من الطبيب.

١٢- تغيير أغطية الفراش بأخرى جافة لزيادة ضياع الحرارة بفعل التوصيل.

ثانياً انخفاض الحرارة

هو نقص حرارة الجسم المركزية عن الحدود الدنيا الطبيعية. هناك ثلاث آليات لنقص الحرارة وهي:

١- زيادة الضياع الحروري.

٢- عدم كفاية إنتاج الحرارة للإعاضة عن فقدان.

٣- انخفاض مستوى بدء التنظيم الحراري المهادي.

أهم العلامات السريرية لنقص الحرارة:

- نقص حرارة الجسم.
- ارتجاف شديد في البداية مع الشعور بالبرد والقشعريرة.
- جلد بارد شاحب شمعي.
- نقص توتر شرياني.
- نقص إنتاج البول.
- عدم توافق التقلصات العضلية.
- عدم توجه.
- وسن يترقى لسبات.

أسباب نقص الحرارة:

- التعرض لحادث مثلاً (التعرض للبرد أو الاستحمام في ماء بارد) أو بشكل محرض.
- عند المسنين نتيجة نقص سرعة الاستقلاب واستخدام المركبات التي تقاوم من نقص سرعة الاستقلاب.

المرضى المعرضون لخطر ارتفاع الحرارة وخطر نقص الحرارة:

١- المعرضون لخطر نقص الحرارة:

- المشتركون برياضات الشتاء كالتزلج وركوب الأمواج.
- الرضع والأطفال الذين لم تنضج آليات تنظيم الحرارة لديهم.
- المسنون الذين يعانون من نقص وارد الأغذية أو نقص الملابس.
- المرضى المصابون بخلل عصبي.
- الكحوليون الذين يفقدون الحرارة نتيجة توسع الأوعية الدموية.
- المشردون الذين يعانون من فقد المأوى والملابس.

٢- المعرضون لخطر ارتفاع الحرارة:

- المصابون بالأخماج.
- المصابون برضوض الرأس.
- المدنفون وهم أشخاص معرضون للتعرض للأخماج.
- الذين يعانون من أمراض الجملة العصبية المركزية.
- حديثي الولادة الذين يعانون من عدم نضج مراكز تنظيم الحرارة.

تدبير نقص الحرارة

- ١- إخراج المريض من الجو البارد وإعادة تدفئته. وفي المرضى المصابين بنقص الحرارة الخفيف تتم التدفئة بالحرايات والبطانيات، أما المصابين بنقص حرارة شديد فتستخدم البطانيات الكهربائية والمزودة بمنظمات لدرجة الحرارة.
- ٢- إعطاء السوائل الوريدية الدافئة.

٣- تغيير الملابس الرطبة بأخرى جافة.

تقييم حرارة الجسم

هناك عدة أماكن لتقييم حرارة الجسم وهي: الفم والشرج والإبط وشاع في السنوات الأخيرة استخدام غشاء الطبل.

١- عن طريق الفم:

المحاسن: مناسبة ومريح وسهلة الاستخدام.

المساوئ: يمكن أن ينكسر الميزان بالعض، لذلك يعتبر غير مستطبل ل: المرضى غير المتعاونون، الأطفال، الفاقدين للوعي، في حالة الصرع لأن الأشخاص يكونون بحالة رعشة. يمكن أن تكون القراءة خاطئة إذا كان المريض مدخن، أو تناول طعام أو شراب بارد أو ساخن لذلك يجب أن تأخذ الحرارة يومياً فمياً على الأقل بعد عشر دقائق من تناولها. غير دقيق في حال كان تنفس المريض من فمه، وقد يؤدي الفم إذا أجري بعد جراحة على الفم.

٢- عن طريق الشرج: Rectal site:

المحاسن: أكثر موثوقية ودقة.

المساوئ: يمكن أن تخرج المريض الواعي وهو مزعج وغير مريح، يمكن أن تسبب أذى للمستقيم بعد الجراحات، يصعب أن يجرى في المريض الذي لا يستطيع أن ينقلب إلى وضعية الاضطجاع الجانبي. وضع الميزان في مواضع مختلفة يعطي قياسات مختلفة. الميزان الشرجي لا يستجيب لتغير الحرارة الشريانية بالسرعة التي يستجيب بها الميزان الفموي. قد ينطمر الميزان بالبراز أو لا يدخل مسافة كافية. قد يؤدي لانتقاب أو تفرح مستقيم أحياناً. وتكون الحرارة الشرجية أكثر من الحرارة الفموية بـ ٠,٥ د.

٣- عن طريق تحت الإبط:

المحاسن: آمنة، وأكثر راحة للمريض.

المساوئ: تأخذ وقت أطول للحصول على القراءة المطلوبة. وتكون أقل من الطريق الفموي بـ ٠,٥ د.

٤- عن طريق غشاء الطبل:

المحاسن: سريع جداً، مقبول، يعكس الحرارة الداخلية، ومناسبة للأطفال، ويمكن الوصول إليه.

المساوئ: غالي الثمن، هناك خطر لإصابة غشاء الطبل إذا أدخل لدرجة بعيدة (عميقاً).

أنواع مقاييس الحرارة:

- مقياس الحرارة الزنبقي الزجاجي: في بعض المؤسسات قد تكون الموازين معلمة باللون مختلفة، مثلاً يستخدم الميزان الأزرق أو الميزان الأحمر لقياس الحرارة الشرجية، بينما يستخدم الميزان الفضي لقياس الحرارة الإبطية أو الفموية.
- مقياس الحرارة الإلكتروني: ويتألف من وحدة إلكترونية متحركة تغذيها بطارية، ومسبر تصله الممرضة بالوحدة الإلكترونية، وغطاء للمسبر، وهما عادةً نبوذان.
- مقياس الحرارة الكيماوية النبوذة: وهو نبوذ ويتكون من نقاط صغيرة من مادة كيماوية يتغير لونها حسب درجة الحرارة.
- الشريط الحساس للحرارة (ميزان الحرارة الجلدي): وهو يقيس درجة الحرارة السطحية، ويطبق عادةً على الجبهة أو البطن.
- مقياس الحرارة الطبلي (الأذني) أو ميزان الأشعة تحت الحمراء: وهو يتحسس الحرارة الصادرة من الجسم على شكل أشعة تحت حمراء، ومصدر الحرارة هنا هو قناة السمع وغشاء الطبل.

التشخيص التمريضية الخاصة بحرارة الجسم:

١- **عالي الخطورة لتغير حرارة الجسم:** هي الحالة التي يكون فيها المريض معرضاً لتغير حرارة جسمه عن الحدود الطبيعية المقبولة بسبب عوامل داخلية، مثل تأثيرات المرض و/أو الأذية على الشخص. الممرضة هنا مسؤولة عن المحافظة على راحة المريض وإماهته وتغذيته بالشكل المناسب. **مرتبط بـ:**

- المرض أو الرض الذي يؤثر على تنظيم الحرارة.
- الأدوية التي تسبب توسع الأوعية أو تقبض الأوعية، أو تغير معدل الاستقلاب أو التركيب.
- عدم الحركة أو كثرة الحركة.

٢- **ارتفاع الحرارة:** هي الحالة التي تزيد فيها حرارة الجسم عن الحدود الطبيعية، أي أعلى من ٣٧,٨ فمويًا، أو ٣٨ شرجياً. **مرتبط بـ:**

- التعرض لحرارة عالية.
- زيادة معدل الاستقلاب.
- التجفاف.

٣- **نقص الحرارة:** هي الحالة التي تنخفض فيها حرارة الجسم عن الحدود الدنيا للمجال الطبيعي، لكن ليس أقل من ٣٥,٦ شرجياً بالنسبة للكحول والأطفال، و ٣٦,٤ شرجياً بالنسبة للمواليد. **مرتبط بـ:**

- التعرض لجو بارد جداً.
- مرض مدنف أو رض.
- عدم كفاية الملابس أو عدم وجود مأوى.

٤- **عدم فعالية تنظيم الحرارة:** هي الحالة التي تتأرجح فيها حرارة المريض بين ارتفاع الحرارة ونقص الحرارة. **مرتبط بـ:**

- نقص معدل الاستقلاب نتيجة التقدم في السن.
- رض أو مرض.